

IPAF — *fokus interpersonalno-afektywny*

Serce 16-sesyjnej terapii DIT: zwięzła formuła łącząca obraz siebie, obraz innych, afekt i obronę. Współtworzona z pacjentem, staje się kotwicą wszystkich interwencji.

CZAS: 25 min Sesje 3-4 (formułowanie); sesje 5-16 (praca z fokusem)

ŹRÓDŁO: Lemma, Target & Fonagy (2011)

JAK UŻYWAĆ

Budujesz centralny fokus terapii DIT (interpersonalno-afektywny fokus, ang. *Interpersonal-Affective Focus*) w czterech składnikach. **Reprezentacja siebie:** jak pacjent widzi siebie w relacjach („jestem ciężarem”). **Reprezentacja innych:** jak doświadcza innych („inni są zajęci sobą”). **Afekt łączący:** emocja generowana przez ten wzorzec (smutek, wstyd, lęk, złość). **Obrona/objaw:** jak pacjent sobie radzi (wycofanie, nadmierna uprzejmość, depresja). Formuła mieści się w 2-3 zdaniach.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Terapia DIT bez fokusu to rozproszone sesje bez kierunku. Fokus jest punktem odniesienia, który nadaje interwencjom spójność; współtworzenie buduje przymierze i zaangażowanie pacjenta. Dobry fokus ma trzy cechy: jest **krótki** (2-3 zdania), **używalny** w dialogu („pamięta Pani nasz wzorzec?”) i pacjent **rozpoznaje** w nim siebie emocjonalnie, nie tylko intelektualnie. Jeśli brzmi jak diagnoza z podręcznika — nie jest dobry.

01

Cztery składniki fokusu

W fazie oceny (sesje 1-3) zbieraj opowieści o relacjach i słuchaj: kim jestem w tych opowieściach? Kim są inni? Wypełnij każdy składnik jednym zdaniem.

REPREZENTACJA SIEBIE

REPREZENTACJA INNYCH

AFEKT ŁĄCZĄCY

OBRONA / OBJAW

02 Sformułuj fokus w 2–3 zdaniach

Wzór: „Anna widzi siebie jako nieważną, innych jako zajętych sobą; gdy aktywuje się ta para, czuje smutek i wstyd, ale tłumi je przez nadmierną uprzejmość i depresję.”

MÓJ FOKUS INTERPERSONALNO-AFEKTYWNY

03 Podziel się z pacjentem i sprawdź

W sesji 3–4 przedstaw fokus pacjentowi. Czy rozpoznaje siebie? Co trzeba skorygować? Fokus musi być wspólny, nie narzucony.

REAKCJA PACJENTA I POTRZEBNE KOREKTY

04 Używaj jako kotwicy

W każdej sesji odwołuj się do formuły: „znów pojawia się ten wzorzec — widzi się Pani jako ciężar, boi się wypowiedzieć potrzebę?”. Zapisz krótką, dialogową wersję.

DIALOGOWA WERSJA FOKUSU

Klucz: dobry fokus jest krótki, używalny w rozmowie i emocjonalnie rozpoznawalny przez pacjenta. To kotwica wszystkich interwencji do końca terapii — jeśli brzmi jak akademicka diagnoza, przeformułuj go prostszym, żywym językiem.